일어설 때 어지러운 이유와 대처

앉거나 누웠다 일어설 때 혈압이 떨어질 수 있습니다. 검사 방법과 생활 속 대처를 알아봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

일어설 때 어지럽다면 혈압을 확인하세요

어지럼이나 넘어짐이 있다면 일어선 뒤 혈압을 재 보세요.

5–30%

지역사회 노인

기립성 저혈압을 겪는 비율

50%

요양시설 거주자

기립성 저혈압을 겪는 비율

2배

5년 사망률

기립성 저혈압이 없는 분과 비교

⚠ 왜 확인하나요?

넘어짐·골절·기절·심장혈관 문제와 관련이 있었습니다. 5년 사망률도 기립성 저혈압이 없는 분보다 약 2배였습니다.

🔍 그래서 확인합니다

65세 이상이거나 여러 약을 드신다면, 일어설 때 어지럼과 넘어짐을 진료 때 꼭 알려 주세요.

실천 · 일어설 때 핑 돌거나 넘어진 적이 있으면 혈압 검사를 요청하세요.

출처 · 마지막 장

언제 떨어지는지도 중요합니다

혈압이 떨어지는 시간에 따라 검사 방법이 달라집니다.

혈압이 바뀌는 때	시점	검사에서 보는 변화
일어선 뒤 몇 분 안에	3분 이내	위 혈압이 20 mmHg 이상 또는 아래 혈압이 10 mmHg 이상 떨어집니다. 누워 있을 때 혈압이 높다면 위 혈압 30 mmHg 이상을 기준으로 봅니다.
일어난 직후 잠깐	15초 이내	위 혈압 40 mmHg 이상 또는 아래 혈압 20 mmHg 이상 떨어졌다가 빠르게 회복합니다. 일어난 직후 재야 놓치지 않습니다.
조금 지난 뒤	3분 이후	늦게 혈압이 떨어질 수도 있어 증상에 따라 더 오래 잽니다. 신경 기능과 관련된 원인도 살펴봅니다.
맥박 또는 누운 혈압 변화	기립 · 누움	혈압이 안 떨어져도 일어서며 맥박이 분당 30회 이상 늘 수 있습니다. 누우면 위 혈압이 140 이상이면서 일어설 때 떨어지는 분도 있습니다.

실천 · 일어난 직후 잠깐만 어지러워도 진료 때 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

일어서면 몸속에서 무슨 일이 생길까요

일어설 때 다리로 쏠린 피를 몸이 보충하지 못하면 어지럽습니다.

정상 보상

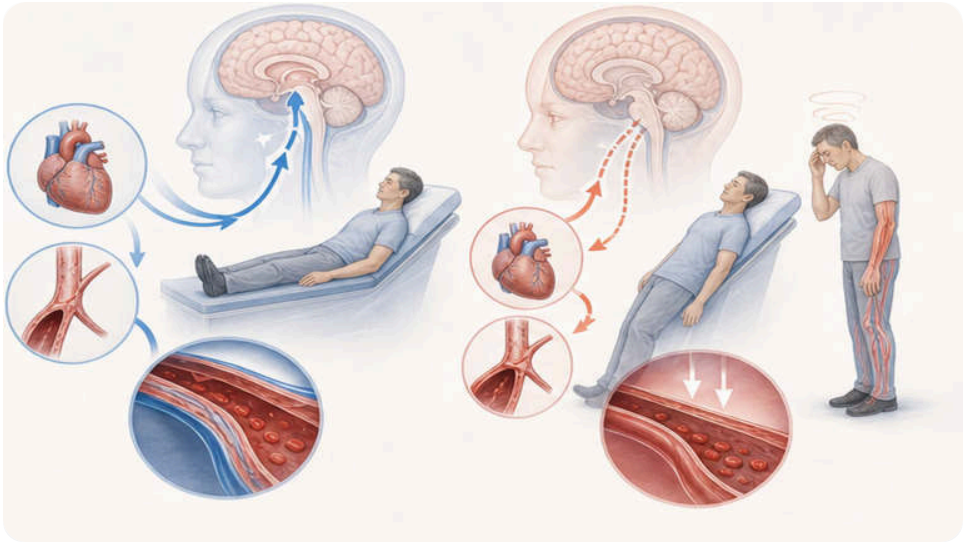
일어서면 피 600–800 ml가 다리로 내려갑니다. 몸은 곧바로 맥박을 +10–20 bpm 높이고 혈관을 좁혀 혈압을 지킵니다.

무너지는 두 갈래

신경이 혈압을 지키라는 신호를 제대로 보내지 못하거나, 탈수·약물·심장 문제로 몸이 반응하지 못할 수 있습니다.

신경성 단서

혈압이 떨어져도 맥박이 15 bpm 미만으로만 늘면 신경 반응에 문제가 있을 수 있습니다.



설명용 그림 · 일어서면 피가 다리로 내려가고, 몸이 맥박과 혈관을 조절해 혈압을 지킵니다.

실천 · 어지러울 때 맥박도 함께 재면 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약과 탈수부터 살펴봅니다

원인에 따라 대처가 달라져 약 목록과 몸 상태를 함께 봅니다.

혈압 조절 신경의 문제

일어설 때 혈압을 지키는 신경 반응이 약한 경우

- 파킨슨병 · 다계통위축증
- 자율신경 기능 저하 · 루이소체 치매
- 당뇨병성 신경 문제 · 아밀로이드증

VS

약·탈수 등 다른 원인

신경 반응은 남아 있으나 몸속 피의 양이나 심장 기능이 부족한 경우

- 탈수·출혈·빈혈 · 심부전·심장판막병·심근경색 후
- 오래 누워 지낸 뒤 체력 저하
- 호르몬 이상 · 심한 감염 · 음주

실천 · 복용 중인 약과 최근 식사·물 섭취량을 함께 알려 주세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

누워서, 일어서서 혈압을 잽니다

누워서 5분 쉰 뒤 일어서서 바로, 1분, 3분에 혈압과 맥박을 기록합니다.

1 누워서 5분 휴식
조용한 곳에서 기준 혈압·맥박수(대화·통화·식후 1시간 이내 측정은 피함).

2 기립 직후(15–30초)
초기형 검출용 — 빠르게 회복돼 놓치기 쉽다.

3 1분 후
흔한 유형이 잘 잡히는 구간.

4 3분 후 · 판정
수축기 20 이상 또는 이완기 10 mmHg 이상 하강이면 기립성 저혈압에 해당합니다.

맥박수 해석

맥박이 15 bpm 미만으로 늘면 신경 반응을, 혈압은 그대로인데 30 bpm 이상 늘면 맥박 문제를 살핍니다. 혈압만 떨어지면 탈수·약·심장 문제를 확인합니다.



설명용 그림 · 누워서 → 일어서서 — 같은 팔로 네 번 잽니다.

실천 · 검사 중 심하게 어지러우면 바로 앉아 넘어짐을 피하세요. 의식을 잃었거나 가슴 통증·숨참이 함께 있으면 응급실로 가세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

복용 중인 약을 함께 확인하세요

약을 스스로 끊기 전에 처방 의사와 복용 시간·용량을 상의하세요.

① 혈압약

일부 혈압약과 소변을 늘리는 약은 일어설 때 혈압을 낮출 수 있습니다. 먹는 약을 모두 보여 주세요.

② 항우울제

삼환계(아미트립틸린·노르트립틸린), SSRI·SNRI(벤라팍신), 트라조돈 — α·항콜린 작용.

③ 항정신병제

클로르프로마진·리스페리돈·올란자핀·쿠에티아핀 — 2세대도 α1 차단으로 유발.

④ 도파민 작용제

레보도파·프라미펙솔·로피니롤 — 파킨슨병 자체와 약이 겹쳐 기여.

⑤ PDE-5 억제제 · 질산염

실데나필·타다라필 + 질산염 병용은 절대 금기. 단독도 위험↑.

⑥ 마약성 진통제 · 기타

트라마돌·모르핀, 1세대 항히스타민, 근이완제, 알코올 — 다약제에서 누적.



실행 · 먼저 복용 시간 조정(기립 위험 시간대 피하기) → 감량 또는 기립성 저혈압에 부담이 적은 약으로 교체. **임의 중단 금지** — 원질환 악화 위험.

실천 · 약 봉투나 처방전 사진을 진료실에 가져오세요. 임의로 끊지 마세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

집에서 실천할 여섯 가지

수분·식사·압박·잠자리와 움직임을 함께 조절합니다.

① 수분 + 염분

하루 물 2 L 이상, 소금 6–10 g을 고려합니다. 심부전·콩팥병이 있으면 스스로 늘리지 말고 담당 의사와 먼저 정하세요.

② 식사 직전 찬물

식사 직전 찬물 240–480 ml를 마시면 식후 혈압 저하를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

③ 압박 스타킹

허리까지 오는 30–40 mmHg 권장. 무릎 길이는 효과 제한적. 아침 기상 전 누운 채 착용.

④ 침대 머리 올리기

침대 머리를 10–20° 올리면 밤에 누웠을 때 높은 혈압과 아침 어지럼을 함께 줄이는 데 도움이 됩니다.

⑤ 다리에 힘을 주는 동작

다리 꼬기·발끝 들기·발 펌프·쪼그려 앉기 — 기립 직전·도중에 혈압을 5–15 mmHg 올린다.

⑥ 피할 것

갑자기 일어서기·뜨거운 샤워·사우나·과식·알코올·더운 환경·장시간 부동·배변 때 강한 힘주기.

실천 · 심부전·콩팥병이 있으면 물·소금 양을 늘리기 전에 꼭 상의하세요.

출처 · 마지막 장

생활 조절 뒤에도 어지러우면

생활 조절과 약 확인 뒤에도 증상이 있으면 치료약을 검토합니다.

의사가 검토할 약	어떻게 돕나요?	복용 중 확인할 점
플루드로코르티손	몸에 물과 소금을 붙잡아 혈압을 올립니다.	칼륨·혈압·부종을 확인합니다. 심부전이나 심한 콩팥병이 있으면 쓸 수 없습니다.
미도드린	혈관을 좁혀 서 있을 때 혈압을 올립니다.	누워 있을 때 혈압이 높아질 수 있어 처방된 복용 시각을 지키세요.
드록시도파	신경 문제로 혈압이 떨어지는 분에게 검토합니다.	국내에서 쓸 수 있는지는 진료실에서 확인합니다.



약 조정은 진료실에서 · 한 약으로 부족하면 의사가 두 약을 함께 쓰거나 다른 약을 검토할 수 있습니다. 누워 있을 때 혈압도 함께 봅니다.

실천 · 혈압을 올리는 약은 누웠을 때 혈압을 높일 수 있어 복용 시각을 지키세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

낮과 밤의 혈압을 함께 봅니다

서 있을 때 낮은 혈압과 누웠을 때 높은 혈압을 같이 기록해야 합니다.

① 취침 전 혈압 측정 필수

자기 전 누워서 잰 혈압을 기록하세요. 180/110 mmHg를 넘으면 진료실에 알려야 간 혈압 대처를 상의합니다.

② 침대 머리 10–20° 거상

침대 머리를 올리면 밤 혈압이 약 10–15 mmHg 낮아지고 아침 어지럼도 줄 수 있습니다.

③ 야간 수축기 200 이상 → 단기 단시간 작용 강압제

밤 혈압이 매우 높으면 의사가 짧게 작용하는 약을 처방할 수 있습니다. 원문에 든 예는 히드랄라진 25 mg 또는 캡토프릴 25 mg입니다. 스스로 복용하지 마세요.

④ 저녁 약 복용 시각 확인

미도드린은 보통 잠들기 최소 4시간 전에 마지막으로 먹습니다. 누워서 잰 혈압이 높으면 의사가 시각이나 용량을 조정할 수 있으니 스스로 바꾸지 마세요.

실천 · 자기 전 누운 혈압과 낮에 선 혈압을 적어 오세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어지럼이 생긴 분의 검사 예

실제 처방은 개인 상태에 따라 달라지는 설명용 사례입니다.

1

환자 · 약물

78세 여성

6개월 전부터 일어설 때 어지럽고 한 번 넘어졌습니다. 소변을 늘리는 혈압약 25 mg, 다른 혈압약 5 mg, 우울증약 50 mg을 먹습니다. 당뇨·콩팥병은 없습니다.

2

누웠다 일어서서 재는 혈압 검사

4시점

기준 145/85·72 → 직후 130/75·76 → 1분 110/70·78 → 3분 100/65·80. 수축기 −45 mmHg, 맥박수 +8(반응 부족).

3

진단

신경성 + 약물 기여

일어선 뒤 수축기 혈압이 45 mmHg 내려갔고 맥박은 8 bpm만 올랐습니다. 신경 반응과 복용약 두 가지를 함께 살핍니다.

4

의사와 조정

2주 뒤 재평가

이 사례에서는 의사가 소변을 늘리는 약을 중단하고 다른 혈압약의 복용 시간을 바꾼 뒤 2주 후 다시 봅니다. 계속 어지러우면 혈압을 올리는 약 0.1 mg을 검토합니다.

실천 · 사례의 약 조정은 따라 하지 말고 본인 처방 의사와 상의하세요.

출처 · 마지막 장

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘부터 기억할 여섯 가지

증상 기록과 약 목록을 진료실에 가져오세요.

1. **일어설 때 어지러우면 혈압 검사**
   누웠다 일어서며 혈압을 재는 검사는 몇 분이면 됩니다.
2. **복용약 확인이 첫걸음**
   복용약을 확인하는 것부터 시작합니다. 약 봉투를 가져오세요.
3. **생활에서 먼저 조절**
   물·소금, 압박 스타킹, 침대 머리 올리기와 피할 상황을 의사와 함께 정합니다.
4. **계속 어지러우면**
   의사가 혈압을 올리는 약을 검토할 수 있습니다. 스스로 약을 바꾸지 마세요.
5. **누웠을 때 혈압도 기록**
   낮과 밤의 혈압을 함께 보고 약 시각을 조정합니다.
6. **호전 없으면 다시 상담**
   필요하면 신경과 등 관련 진료과와 함께 원인을 찾습니다.

SCAN TO REVISIT

슬라이드 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

Moloney D 외, JAMA Intern Med 2026, doi:10.1001/jamainternmed.2026.0284 · AAS/EFAS 2011 · Beers Criteria 2023